SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 2
OBJETIVOS 3
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 3
ADMISSÃO DA GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO 4
ASSISTÊNCIA NO PRIMEIRO PERÍODO DO PARTO 4
Tabela 2 – Períodos clínicos do parto 6
Orientações hemoterápicas considerando o risco de hemorragia pós-parto (HPP) 6
Controle da dor no trabalho de parto 7
Observações e avaliações durante o trabalho de parto 8
Tabela 3 – Classificação do traçado cardiotocográfico (FIGO) 10
ASSISTÊNCIA NO SEGUNDO PERÍODO DO PARTO 11
Tabela 4– Dosagens e preparo de ocitocina: 12
ASSISTÊNCIA AO TERCEIRO PERÍODO DO PARTO 13
AÇÕES, CUIDADOS E VIGILÂNCIA MATERNA NO PÓS-PARTO 17
CRITÉRIO DE SAÍDA DO PROTOCOLO 18
MONITORAMENTO 18
CONFLITOS DE INTERESSE 18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
SIGLAS 22
HISTÓRICO DAS VERSÕES 23

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

INTRODUÇÃO

A assistência à gestante em trabalho de parto deve vir ao encontro das diretrizes de boas práticas em saúde centradas em sua saúde, de seu bebê e de sua família.

A equipe multiprofissional deve proporcionar atenção qualificada incentivando o parto normal sempre que as condições materno-fetais forem seguras. Deve também promover a expressão da sensibilidade no ambiente do cuidado, integrando acompanhantes e familiares, reconhecendo a fisiologia do processo de parto e nascimento, propiciando o protagonismo da mulher e respeitando, tanto para ela quanto para seu bebê, os direitos humanos e a cidadania.

O trabalho em equipe multidisciplinar deve ser efetivo e harmonioso. A comunicação entre os seus membros deve ser assertiva, de forma a promover o cuidado seguro e o melhor funcionamento do serviço. Nas passagens de plantão, deve-se utilizar a ferramenta ISBAR para a transferência do cuidado. Os casos devem ser discutidos pela equipe, definindo-se as condutas mais apropriadas a serem tomadas coletivamente.

Os princípios do modelo de assistência e promoção do parto seguro no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) são:

- Vinculação da gestante à unidade de referência para assistência ao parto, permitindo visitas e acolhendo-a para que conheça a maternidade.
- Promoção de boas práticas de atenção e da presença de acompanhante de escolha da mulher.
- Atuação de profissionais de diferentes categorias e saberes, que trabalhem de forma integrada, a fim de estabelecer o cuidado adequado para o binômio mãe-neonato.
- Proposição do acesso ao planejamento reprodutivo pós-parto.
- Formação de profissionais de saúde embasada nas melhores práticas, consoante com evidências científicas que promovam o entendimento da fisiologia e o cuidado do conjunto binômio-família.

Destaca-se que a participação dos discentes no cuidado é de grande benefício para a parturiente:

- O aluno deve ter orientações sobre as boas práticas na assistência ao parto e nascimento. Como parte da equipe, deve apoiar a utilização das práticas baseadas em evidências, com postura crítica e proativa.
- O aluno, sob supervisão, deve oferecer informações às mulheres e familiares acerca do cuidado em saúde para que estes possam fazer escolhas informadas. Deve, também, encorajar a participação ativa da mulher em todo o processo.
- O aluno, sob supervisão, deve permanecer na cena do parto, em sintonia com a situação - já que

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

toda presença interfere no processo. Assim como todos os profissionais da equipe multidisciplinar, ele deve evitar entradas intempestivas e pontuais, apenas para observar a cena do parto ou procedimentos técnicos, considerando a promoção do cuidado seguro.

- O aluno que estabelecer vínculo com a paciente e sua família poderá atuar na assistência sob supervisão do preceptor ou professor.
- O número de alunos no acompanhamento do parto e trabalho de parto deve ser o menor possível, não devendo exceder um aluno por categoria ou especialidade.
- A presença de alunos na assistência não deverá ser elemento motivador para realização de intervenções clínicas ou cirúrgicas desnecessárias.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Promover assistência ao trabalho de parto e ao nascimento sistematizada, qualificada e segura, baseada nas melhores evidências científicas disponíveis, de forma interdisciplinar, com ações e responsabilidades compartilhadas pela equipe multiprofissional, sempre direcionadas ao bem-estar do binômio.

Objetivos Específicos

- Garantir a qualidade da assistência prestada às mulheres, a seus bebês e a suas famílias, proporcionando-lhes cuidado efetivo e seguro.
- Fortalecer o trabalho multiprofissional coeso e colaborativo, baseado na capacitação técnica e legal dos membros da equipe, com a adoção de práticas baseadas em evidências científicas.
- Reduzir intervenções desnecessárias no processo de assistência ao parto e nascimento e, consequentemente, os seus agravos.
- Contribuir para a formação humanística e ética dos profissionais.

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

Gestantes em trabalho de parto ativo, ou que evoluíram para essa fase após o processo de indução do trabalho de parto, admitidas na Maternidade Otto Cirne do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

ADMISSÃO DA GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO

Mulheres em trabalho de parto devem ser tratadas com respeito, ter acesso às informações baseadas em evidências e serem incluídas na tomada de decisões. Para isso, os profissionais que as atendem deverão estabelecer uma relação de confiança com as mesmas, perguntando-lhes sobre seus desejos e expectativas. Devem estar conscientes da importância de sua atitude, do tom de voz e das próprias palavras usadas, bem como a forma como os cuidados são prestados.

Quando diagnosticado o trabalho de parto em fase ativa (contrações regulares e dilatação cervical maior ou igual a 4 cm), nas gestações de baixo risco, deve-se proceder à admissão da paciente, com emissão da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), e comunicar a internação aos demais membros da equipe.

A assistência ao parto de baixo risco pode ser feita pelos residentes, desde que supervisionados por seus preceptores. É importante a comunicação entre os membros da equipe sobre a condução dos períodos do parto e, em caso de anormalidades, o médico obstetra deverá ser comunicado e solicitada a sua presença para avaliação.

O preceptor da obstetrícia é o profissional responsável por fazer a classificação das pacientes em alto e baixo risco, indicando os profissionais prioritariamente responsáveis acompanhamento. A assistência ao parto de alto risco deve ser liderada pelo médico obstetra, assim como a condução no 2º e 3º períodos do parto, estando os demais profissionais da equipe inseridos no cuidado.

A elaboração do plano de cuidados pela equipe multidisciplinar deverá contar com a participação da mulher e acompanhante, considerando o quadro clínico e o plano de parto. Os profissionais deverão lhe expor esse plano de cuidados, bem como orientar sobre os métodos não farmacológicos e farmacológicos para alívio da dor, incluindo seus riscos e benefícios.

ASSISTÊNCIA NO PRIMEIRO PERÍODO DO PARTO

No primeiro período do parto há o surgimento de contrações uterinas e o início do processo de dilatação do canal vaginal e do colo uterino, até que ele atinja 10 cm. Sua duração pode variar de mulher para mulher. A duração do trabalho de parto ativo pode variar:

Tabela 1 – Duração média e percentil 95 para pacientes primíparas e multíparas, segundo a dilatação inicial.

Paridade	Dilatação inicial	Duração média (horas)	Percentil 95 (horas)
Primíparas	4 cm	3,7 a 5,9	14,5 a 16,7
	5 cm	3,8 a 4,3	11,3 a 12,7
	6 cm	2,9	9,5

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Paridade	Dilatação inicial	Duração média (horas)	Percentil 95 (horas)
Multíparas	4 cm	2,2 a 4,7	13 a 14,2
	5 cm	3,4	10,8
	6 cm	2,4	7,5

- A gestante pode caminhar, desde que se garanta a sua segurança, e isso pode ajudar no posicionamento do feto. Quando ela estiver deitada, deve-se orientar e incentivar a permanência em decúbito lateral esquerdo (DLE), para facilitar a melhor circulação uterina e diminuir a dor.

- Deve-se realizar a avaliação do colo uterino no mínimo de 4 em 4 horas quando a dilatação for inferior a 6 cm. Após 6 cm, a frequência mínima deverá ser de 2 em 2 horas. Avaliações com menor frequência devem ser individualizadas e realizadas se houver alguma preocupação com o progresso do trabalho de parto ou por solicitação da mulher.

- Mulheres em trabalho de parto podem ingerir líquidos, de preferência soluções isotônicas ao invés de somente água, para diminuir o risco de desidratação que se associa à atividade física e à frequente hiperventilação.

- Mulheres em trabalho de parto que não estiverem sob efeito de opióides e não apresentarem fatores de risco iminente para anestesia geral podem ingerir uma dieta leve.

- Deve-se permitir à parturiente escolher a posição que lhe for mais confortável. O profissional pode orientá-la a assumir posições que facilitem a evolução do trabalho de parto.

- Objetiva-se promover um ambiente mais privado, tranquilo e seguro, podendo-se utilizar música, penumbra ou outros artifícios para torná-lo mais agradável para a mulher e seu acompanhante.

- As mulheres que tiverem recebido opioides ou que apresentarem fatores de risco que aumentem a chance de uma anestesia geral devem receber antagonistas H2 ou antiácidos. Esses medicamentos não devem ser utilizados de rotina para mulheres de baixo risco para anestesia geral durante o trabalho de parto.

- Mulheres em trabalho de parto que progridem espontaneamente podem não necessitar de infusão contínua de fluidos endovenosos (EV). Embora segura, a hidratação EV limita a liberdade de movimento e pode ser dispensada, em decisão compartilhada com paciente.

- A avaliação do débito urinário pode ser usada para monitorar a hidratação. Se tal monitoramento indicar desidratação, fluidos intravenosos podem ser administrados, conforme necessário. O tipo de solução e a taxa de infusão devem ser determinadas pela necessidade clínica individual e pela duração prevista do trabalho de parto.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Tabela 2 – Períodos clínicos do parto

PERÍODOS CLÍNICOS DO PARTO			
PERÍODOS		**CARACTERÍSTICAS**	
1º Período	DILATAÇÃO	FASE DE LATÊNCIA	Período não necessariamente contínuo: - há contrações uterinas dolorosas - há alguma modificação cervical, incluindo apagamento e dilatação até 4 cm.
		TRABALHO DE PARTO ATIVO	Há contrações uterinas regulares e dilatação cervical progressiva a partir dos 4 cm.
2º Período	PERÍODO EXPULSIVO	**Fase inicial ou passiva**: dilatação total do colo sem sensação de puxo involuntário ou parturiente com analgesia e a cabeça do feto ainda relativamente alta na pelve. **Fase ativa**: dilatação total do colo, cabeça do bebê visível, contrações de expulsão ou esforço materno ativo após a confirmação da dilatação completa do colo do útero na ausência das contrações de expulsão.	
3º Período	DELIVRAMENTO	DEQUITAÇÃO	Momento desde o nascimento da criança até a expulsão da placenta e membranas. A condução ativa do terceiro período envolve um pacote de intervenções com os seguintes componentes: uso rotineiro de drogas uterotônicas, clampeamento e secção oportuna do cordão umbilical e tração controlada do cordão, por profissional treinado, após sinais de separação placentária.
4º Período	PERÍODO DE GREENBERG ou de OBSERVAÇÃO		Corresponde a 1-2 horas após a dequitação. Nesse período dá-se a hemostasia uterina através de: miotamponamento uterino (ligaduras vivas de Pinard), trombotamponamento uterino, indiferença mio-uterina e contração uterina fixa (globo de segurança).

Orientações hemoterápicas considerando o risco de hemorragia pós-parto (HPP)

As gestantes em trabalho de parto devem ser estratificadas quanto ao risco de HPP (Bienstock et al, 2021) e os casos com alto risco devem ser discutidos com o hemoterapeuta de plantão, a fim de que haja a preparação adequada da Agência Transfusional para prontamente atender à eventual demanda transfusional.

O atendimento hemoterápico em situações de emergência sem preparo prévio se associa a maiores riscos, tanto relacionados à transfusão de hemácias sem prova de compatibilidade quanto ao atraso no atendimento com todas as suas consequências – visto que estoques de hemácias O negativo têm se mantido críticos, e que há necessidade de descongelar o plasma, o que demora entre 30 e 40 min.

Deve-se incluir a coleta de amostra para prova de compatibilidade e a reserva de hemocomponentes, pelo menos para as gestantes classificadas como médio e alto risco de HPP, conforme descrito no Protocolo de Transfusão Maciça (fluxo 4). Pode ser interessante, ainda, a coleta de exames como hemograma, coagulograma, fibrinogênio e cálcio iônico dessas gestantes, para conhecimento do "basal", que poderá orientar no manejo hemoterápico da HPP.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Controle da dor no trabalho de parto

Durante o primeiro período do trabalho de parto, a mulher pode sentir dores devido às contrações, que ficam mais frequentes à medida que evolui a dilatação do colo do útero e do canal vaginal. O controle dessas dores tem como objetivo dar apoio à mulher, aumentar seu limiar para as sensações dolorosas e contribuir para uma experiência positiva de parto.

Uma mulher em trabalho de parto não deve ser deixada sozinha, exceto por curtos períodos de tempo ou por sua solicitação. Ela deve ter acompanhantes de sua escolha durante parto e o trabalho de parto, não invalidando o apoio dado por pessoal de fora da rede social da mulher.

Métodos não farmacológicos de alívio da dor

- Incentivo à verticalização,
- Controle da respiração,
- Sempre que possível, oferecer banho de aspersão,
- Técnicas de relaxamento,
- Massagens,
- Uso de bola suíça,
- Suporte de doula.

Esses métodos devem ser oferecidos à parturiente, independentemente da utilização de métodos farmacológicos. Deve-se oferecer informação quanto aos riscos e benefícios dos métodos farmacológicos e não farmacológicos para alívio da dor, quando eles forem indicados.

Indicação de métodos farmacológicos de alívio da dor

A solicitação da parturiente por analgesia no parto após essas orientações configura indicação suficiente para sua realização, independentemente da fase do parto e do grau de dilatação. A analgesia peridural já pode ser iniciada desde o início da fase ativa da dilatação, se for o desejo dessa paciente. Ela pode levar a maior necessidade de uso de ocitocina no primeiro período do trabalho de parto e a um segundo período ligeiramente mais longo, aumentando a incidência de parto vaginal instrumental; além da necessidade de um nível mais elevado de monitoração e da possibilidade de ter a mobilidade reduzida.

Cuidados após a realização de analgesia regional

- A gestante deve ser avaliada quanto à ocorrência de hipotensão arterial, devendo-se considerar, individualmente, a necessidade de hidratação ou suporte com substâncias vasoativas.
- A gestante sob analgesia peridural, quando se sentir confortável e segura, deve ser encorajada a deambular e adotar posições mais verticais, desde que garantida a sua segurança.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Após confirmação da dilatação completa, não se deve incentivar a gestante a realizar puxos, exceto quando tardiamente (no mínimo após 1 hora de dilatação total) ou quando a cabeça fetal se tornar visível.
- Os puxos devem ser efetivados durante as contrações.
- Após constatados 10 cm de dilatação, como ponto de boa prática, devem ser estabelecidas estratégias para que o nascimento ocorra em até 3 horas, independentemente da paridade.
- Não é recomendação de rotina a administração de ocitocina após analgesia regional.
- A gestante submetida a analgesia de parto deverá ter monitorização básica instalada – pressão arterial não invasiva a cada 5 min, frequência cardíaca e oximetria de pulso – por no mínimo 30 min.
- No início da analgesia regional e nas doses adicionais de resgate, seja qual for a técnica, a parturiente deve ser submetida a ausculta da frequência cardíaca fetal (FCF) de 5 em 5 minutos por no mínimo 30 minutos. Em caso de anormalidade, deve-se instalar cardiotocografia (CTG), colocá-la em DLE e avaliar a necessidade de otimização das condições respiratórias e circulatórias (melhorar o fluxo sanguíneo uterino, o fluxo sanguíneo umbilical e a oxigenação; diminuir a atividade uterina).
- Se ocorrerem anormalidades fetais graves, não transitórias, considerar outra causa que não analgesia regional e seguir diretrizes próprias para a condução de estado fetal não tranquilizador.
- Todo cateter peridural deve ser retirado pelo médico anestesiologista.

Observações e avaliações durante o trabalho de parto

A assistência profissional ao parto demanda a manutenção do bem-estar da parturiente e do feto, bem como a avaliação da progressão do trabalho de parto. Para isso, uma série de observações devem ser realizadas, visando detectar problemas que possam exigir intervenção.

- Deve-se avaliar os sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar) a cada 4 horas – ou em intervalos menores, nas situações de maior gravidade.
- Utiliza-se o partograma para os registros da fase ativa do trabalho de parto. Ele deve ser preenchido obrigatoriamente em casos de gestações únicas, no termo e com apresentação cefálica. Para pacientes no trabalho de parto em outras condições, ele também pode ser preenchido, apenas para o registro da evolução.
- Deve conter dados relativos a: 1) identificação da paciente, conforme NO nº 019; 2) dilatação do colo, variedade de posição e altura do feto; 3) frequência cardíaca fetal; 4) estado das membranas e, se rotas, aspecto do líquido amniótico (cor, odor); 5) dinâmica uterina; e 6) uso ou não de ocitocina, bem como os incrementos realizados.
- Em gestantes recebendo ocitocina, a dinâmica uterina deve ser realizada cada 30 minutos ou sempre que as condições clínicas indicarem. Nessa avaliação, deve-se verificar o número de

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

contrações e a sua duração em segundos, durante um período de 10 minutos. Realiza-se a ausculta fetal contínua, a fim de avaliar a presença de desacelerações antes, durante ou após as contrações.

- Preconiza-se avaliar e registrar FCF a cada 30 minutos nas gestações de baixo risco e a cada 15 minutos nas de alto risco. No período expulsivo, a ausculta deve ser realizada a cada 5 minutos ou após cada contração, pelo período mínimo de 1 minuto. Consideram-se normais os batimentos que variam entre 110 e 160 bpm, excetuando-se os períodos de acelerações (por exemplo, durante movimentação fetal).
- Se houver alterações na ausculta fetal, orienta-se posicionar a gestante em DLE, ou realizar mudança de posição se a parturiente já estiver nessa posição, oferecer oxigênio (O2) suplementar por máscara facial a 8 L/min, realizar exame cervical e avaliar a necessidade de CTG.
- Quando houver rotura das membranas, avaliar as características do líquido amniótico e realizar a ausculta fetal por no mínimo 1 minuto.
- A ausculta intermitente é indicada na avaliação da vitalidade fetal nos trabalhos de parto de baixo risco, não se indicando o uso rotineiro de CTG intraparto. Entretanto, a monitorização contínua da CTG pode ser considerada nas situações com alto risco de hipoxia ou acidose fetal, sejam elas:
  - condições maternas como hemorragia vaginal e pirexia,
  - crescimento fetal anormal durante a gravidez,
  - presença de líquido amniótico meconial,
  - possibilidade de atividade uterina excessiva, como ocorre no trabalho de parto induzido,
  - quando anormalidades são detectadas durante a ausculta fetal intermitente.
- Deve-se proceder com o exame cervical avaliando dilatação, apagamento, consistência e posição do colo, a variedade de posição e a altura da apresentação do feto e a integridade da bolsa amniótica. A frequência mínima dessa avaliação é de 4 em 4 horas, mas depende do contexto do cuidado e do progresso do trabalho de parto, podendo ser postergada ou adiantada conforme sinais e comportamento da mulher.

Avaliação do médico obstetra

Quando o acompanhamento realizado pela enfermagem apresentar algum dos parâmetros listados abaixo, deve-se solicitar a assistência do médico obstetra:

- FC materna > 120 bpm em 2 ocasiões com 30 minutos de intervalo.
- PAS ≥ 160 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg em uma única medida.
- PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg em 2 medidas consecutivas com 30 min de intervalo.
- PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg se houver proteinúria de fita 1+ ou mais.
- Temperatura ≥ 38°C (1 medida) ou ≥ 37,5°C (2 ocasiões consecutivas), com 1 h de intervalo.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Presença de líquido amniótico meconial ou fétido.
- Dor relatada pela mulher que difere da dor normalmente associada às contrações.
- Progressão lenta da dilatação.
- Emergência obstétrica, incluindo hemorragia anteparto, prolapso de cordão, convulsão ou colapso materno.
- Situação transversa ou oblíqua, e qualquer apresentação anômala.
- Suspeita de restrição de crescimento intrauterino ou macrossomia.
- Suspeita de anidramnia ou polidramnia.
- Alterações na FCF à ausculta intermitente ou CTG suspeita ou anormal (FIGO – tabela 2).
- Alterações na atividade uterina.

Tabela 3 – Classificação do traçado cardiotocográfico (FIGO)

	Normal	Suspeito	Anormal
Linha de base	110 – 160 bpm	Ausência de pelo menos um critério de normalidade, mas sem nenhum critério de patológico	< 100 bpm
Variabilidade	5-25 bpm		Variabilidade reduzida, variabilidade normal, padrão sinusoidal.
Desacelerações	Sem desacelerações repetitivas*		Desacelerações repetitivas* (tardias ou prolongadas) > 30 min ou se ↓ Variabilidade > 20 min Variabilidade > 5 min
Interpretação	Sem hipóxia/ acidose	Baixa probabilidade de hipóxia/acidose	Alta probabilidade de hipóxia/acidose
Orientação clínica	Não é necessária qualquer intervenção para melhorar a oxigenação fetal	Ação para corrigir causas reversíveis se identificadas, monitorização criteriosa ou métodos adjuvantes	Ação imediata para corrigir causas reversíveis, métodos adjuvantes ou, se não for possível, parto imediato. Em situações agudas, deverá ser realizado parto imediato

***** As desacelerações são repetitivas quando associadas a mais de 50% das contrações. A ausência de acelerações durante o trabalho de parto tem significado incerto.

Considerações sobre intervenções com uso rotineiro desaconselhadas

Alguns procedimentos, antigamente rotineiros, não possuem indicação clara, além de trazerem seus próprios riscos:

- A realização de enemas evacuantes de rotina não melhora os desfechos maternos ou neonatais e tampouco a satisfação materna com a assistência, mas pode ser considerada em pacientes com constipação intestinal.
- A tricotomia pubiana e perineal no trabalho de parto não mostra benefícios clínicos, não devendo ser realizada de forma rotineira.
- A amniotomia precoce não deve ser realizada de rotina em mulheres em trabalho de parto que

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

estejam progredindo bem. Deve ser reservada para quando houver progressão comprometida do trabalho de parto e executada com material apropriado durante a contração uterina. Ela pode estar associada a desacelerações variáveis e risco de prolapso de cordão. A intervenção é contraindicada em gestantes portadoras do HIV.

- Se houver necessidade da utilização de ocitocina no primeiro período do parto, deve-se assegurar que os incrementos na dose não sejam mais frequentes do que a cada 30 minutos. Os incrementos devem ser realizados somente após a realização da dinâmica uterina, assegurando a segurança do cuidado. Aumentar a dose até que se obtenha padrão satisfatório de contração (máximo de 5 contrações em 10 minutos).

> Taquissistolia é frequência excessiva de contrações, definida como a ocorrência de mais de 5 contrações em 10 minutos, em dois períodos sucessivos de 10 minutos, ou em média, ao longo de um período de 30 minutos.

- Existem evidências demonstrando que regimes de altas doses de ocitocina para estimulação do trabalho de parto estão associados a trabalhos de parto mais rápidos, menor taxa de cesarianas, principalmente por distócia, mais partos vaginais espontâneos e menos corioamnionite. Entretanto, o aumento das doses com frequência maior do que a cada 30 minutos pode se associar a hiperestimulação uterina e padrões não tranquilizadores da frequência cardíaca fetal. Deve-se ter cautela em relação ao seu uso rotineiro, tendo em vista a heterogeneidade dos estudos e a carência de evidências em relação aos desfechos neonatais.

ASSISTÊNCIA NO SEGUNDO PERÍODO DO PARTO

O 2º período do trabalho de parto começa quando há a dilatação total do colo uterino e se encerra com a expulsão do concepto. Esse início anatômico pode ou não coincidir com o início da fase de expulsão, quando a mãe começa a sentir desejo de empurrar. Algumas mulheres sentem esse desejo antes de ter colo completamente dilatado; outras podem senti-lo bem depois da sua dilatação total.

Em relação ao segundo período do parto, são consideradas as seguintes fases:

- **Fase passiva/transição**: dilatação total do colo sem sensação de puxo involuntário, polo cefálico relativamente alto na pelve.
- **Fase ativa**: dilatação total do colo, polo cefálico visível (baixo), contrações de expulsão ou puxo involuntário.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- O profissional, durante a assistência ao segundo período do parto, deve incentivar a mulher a experimentar posições que promovam o conforto e a boa circulação uterina.
- Tanto a técnica de "mãos sobre" (proteger o períneo e flexionar a cabeça fetal) quanto a técnica de "mãos prontas" (com as mãos sem tocar o períneo e a cabeça fetal, mas preparadas para tal) podem ser utilizadas para facilitar o parto espontâneo.
- Se a técnica de "mãos sobre" (manobra de *Ritgen*) for utilizada, controlar a deflexão da cabeça e orientar à mulher para não empurrar nesse momento.
- Deve-se evitar a realização de puxo dirigido, aguardando-o ocorrer espontaneamente em mulheres sem analgesia. Quando o puxo espontâneo for ineficaz ou quando solicitado pela mulher, deve-se oferecer opções para auxiliar o nascimento, tais como mudança de posição e esvaziamento de bexiga. Após uma hora de dilatação completa, a mulher deve ser incentivada a realizar o puxo dirigido durante as contrações.
- Caso o parto não ocorra em até 2 horas subsequentes ao início da fase ativa do segundo período do parto em mulheres nulíparas, deve-se solicitar a avaliação do médico obstetra para definição da conduta. Em multíparas, será considerado o intervalo de até uma hora para essa solicitação.
- Nessas situações de prolongamento do segundo período do parto, deve-se discutir a necessidade do uso de ocitocina e de amniotomia.
- Se não houver resposta adequada a essas intervenções, ou se não houver segurança quanto ao bem-estar fetal, considerar o uso de parto instrumental com vácuo extrator ou fórceps, a depender das circustâncias clínicas e da experiência do profissional. Nessas situações, também pode ser considerada e necessidade de realização da operação cesariana.

Tabela 4– Dosagens e preparo de ocitocina:

	Baixa dose			Alta dose		
	Dose (mU/min)	mL/h	gotas/min	Dose (mU/min)	mL/h	gotas/min
Início	1 a 2	6 a 12	2 a 4	4 a 6	24 a 36	8 a 12
Incremento (a cada 30 min)	1 a 2	6 a 12	2 a 4	4 a 6	24 a 36	8 a 12
Dose máxima	20	120	40	40	240	80

Preparo:	1 ampola de ocitocina (5UI) em 500 ml de SF 0,9%
Solução:	1 ml (20 gotas) equivale a 10 mU de ocitocina
Bomba de infusão:	6 ml/h = 1mU/min
Gotejamento:	2 gotas/min = 1mU/min

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Cuidados com o períneo

- Massagens perineais na segunda etapa do trabalho de parto não resultam em melhores resultados para o períneo. O uso de spray de lidocaína não está associado a redução da dor perineal, mas pode estar associado a redução no trauma perineal.
- Considerar aplicação de compressas mornas no períneo no segundo período do parto.
- A episiotomia de rotina deve ser evitada. Seu uso rotineiro não apresenta benefícios para as parturientes, quer em curto ou longo prazo, em comparação com o uso restritivo. Ela deverá ser considerada – e sua indicação deve ser registrada em prontuário – quando houver:
  - necessidade de parto operatório,
  - variedade de posição em OS (occipto-sacra),
  - sofrimento fetal agudo,
  - peso fetal estimado superior a 3.500 g,
  - período expulsivo prolongado e períneo muito resistente, segundo a avaliação do profissional assistente.
- A episiotomia deverá ser médio-lateral, originando a 0,5 cm da fúrcula vaginal e sendo direcionada para o lado direito, com ângulo do eixo vertical entre 45° e 60°. É imprescindível assegurar analgesia efetiva antes da sua realização.

ASSISTÊNCIA AO TERCEIRO PERÍODO DO PARTO

O terceiro período do parto se inicia com o nascimento da criança e vai até o desprendimento e expulsão da placenta e das membranas. Considera-se prolongado após 30 minutos de manejo ativo.

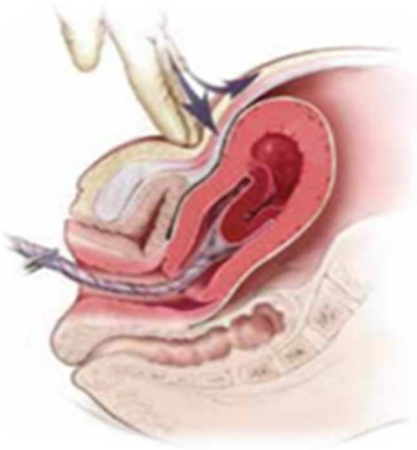
Nesse período, os profissionais assistentes devem ter como objetivo minimizar a ocorrência de eventos adversos como perda sanguínea acima do esperado e retenção placentária, buscando proporcionar que os processos do puerpério se mantenham fisiológicos, e lembrando de auxiliar e apoiar a vinculação entre a mãe e o recém-nascido (RN).

A conduta ativa durante o terceiro período do parto inclui o uso profilático de ocitocina e o clampeamento oportuno do cordão umbilical, que deve ocorrer entre o 1º e 3º minuto de vida – exceto nas mães portadoras do HIV, na necessidade de reanimação neonatal e nos recém-nascidos menores que 34 semanas de idade gestacional, quando o clampeamento deve ocorrer em até 30 segundos – com tração controlada do cordão para desprendimento da placenta.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Condutas no terceiro período do parto

- O manejo ativo do terceiro período do parto consiste no uso combinado de ocitocina e tração controlada do cordão, e está associado com menor risco de hemorragia e transfusão sanguínea.
- A ocitocina deve ser administrada em todas as puérperas, por via intramuscular, como profilaxia para hemorragia, na dose de 10 Ul, imediatamente após o desprendimento do ombro anterior ou após o nascimento, antes do clampeamento e corte do cordão umbilical. A ocitocina está associada a menos efeitos colaterais, se comparada a uterotônicos como os ergotamínicos.



- A tração controlada do cordão, como parte do manejo ativo, só deve ser realizada após a administração de ocitocina. Ela consiste na tração combinada com contrapressão sobre o corpo uterino na direção cefálica, conforme mostra a figura ao lado. Realiza-se a ligadura do cordão umbilical com uma pinça anatômica próximo ao períneo, segura-se o cordão clampeado com uma das mãos e realiza-se, concomitantemente, a compressão suprapúbica com a outra mão, para estabilização uterina.

Revisão da placenta, dos anexos e do canal de parto:

- Deve-se proceder com o exame macroscópico da placenta, cordão umbilical e membranas imediatamente após a expulsão, para verificar a integridade dos cotilédones, das membranas e do cordão umbilical, certificando-se de que não foram deixados restos na cavidade uterina.
- Se a integridade da placenta e das membranas for duvidosa, a revisão com exploração da cavidade uterina deve ser realizada. O exame da placenta e anexos é importante também para o diagnóstico de eventuais anormalidades, como infartos, hematomas, inserção anormal de cordão e artéria umbilical única.
- A revisão perineal ou revisão do canal de parto para o diagnóstico de possíveis lacerações de trajeto deverá ser realizada pelos mesmos profissionais que tiverem assistido ao parto. A sutura de lacerações ou eventuais episiorrafias deverão ser realizadas nesse momento.
- Realizar a reparação do trauma perineal utilizando técnica asséptica. Uma boa iluminação é essencial para identificar as estruturas envolvidas.
- Assegurar analgesia efetiva. Se a mulher relatar alívio inadequado da dor a qualquer momento, deve-se levar isso em consideração imediatamente e providenciar método mais eficaz de alívio.
- Se houver necessidade de sutura da pele, utilizar uma técnica subcutânea contínua.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

- Realizar a reparação perineal usando uma técnica de sutura contínua para a camada de parede vaginal e músculo.
- Recomenda-se a utilização de material de sutura sintética de absorção rápida (poligalactina, ácido poliglicólico, catgut simples ou cromado) para suturar o períneo.
- Traumas perineais de 3º e 4º graus só devem ser manejados por médico obstetra com treinamento adequado em avaliação e reparo perineal ou por médico residente sob supervisão direta.
- Deve-se realizar toque retal após o término do reparo perineal dos traumas de 3º e 4º graus para identificar se o fio transpassou acidentalmente a mucosa retal. Caso isso aconteça, o fio deve ser cortado e essa sutura removida.
- Orienta-se registrar detalhadamente no prontuário a da extensão do trauma, o método de reparação e os materiais usados.

Uso de profilaxia antimicrobiana:

Quadro 1 – Tratamento antimicrobiano profilático para o parto:

- INDICAÇÕES:
  - Cesariana: todas as pacientes submetidas a cesariana eletiva ou intraparto.
  - Parto vaginal: uso de fórceps ou vácuo-extrator, extração manual da placenta, curetagem pós-parto, presença de lacerações de 3º ou 4º grau.
- ESQUEMAS:
  - Cefazolina 2 g EV, pacientes com peso < 120 Kg.
  - Cefazolina 3 g EV, pacientes com peso ≥ 120 Kg.

→ Pacientes com alergia a penicilinas: clindamicina 900 mg EV.
→ Pacientes submetidas a cesariana intraparto, ASSOCIAR azitromicina 500 mg EV.

Fonte: PR 325 - Normas e rotinas para o uso de antibióticos em Obstetrícia

Complicações maternas relacionadas ao terceiro período do parto

- Qualquer complicação materna ou anormalidade anatômica verificada deverá ser comunicada ao médico obstetra do plantão, que deverá avaliá-la.
- Puérpera e acompanhante deverão ser informados sobre as intercorrências ou complicações, e sobre os procedimentos previstos.
- Caso seja necessária a extração manual da placenta, a mesma deverá ocorrer sob o efeito de anestesia adequada.
- A assistência à puérpera com hemorragia pós-parto (HPP) demanda avaliação cuidadosa e precoce, buscando-se identificar suas causas, dimensionar sua intensidade e corrigir a perda sanguínea em tempo hábil, evitando-se a descompensação clínica materna.
- Diante da perda sanguínea excessiva, quando identificada a causa do sangramento, deve-se

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

instituir o tratamento específico, considerando os quatro fatores que podem se relacionar à HPP (os "quatro Ts"): atonia uterina (tônus), lacerações do canal de parto (trauma), retenção de fragmentos placentários na cavidade uterina (tecido) e distúrbios de coagulação (trombina).

- Na vigência de HPP, não se deve esperar por sinais clássicos de instabilidade hemodinâmica para o início do tratamento.
- Deve-se garantir a coleta de exames de urgência e providenciar dois acessos venosos calibrosos.
- Diante de hemorragia pós-parto com descompensação hemodinâmica, deve-se ativar o Protocolo de Transfusão Maciça ou o Protocolo de Transfusão de Hemocomponentes em situação de Emergência.

Quadro 2 – Ativação do Protocolo de Transfusão Maciça:

Contato com a Agência Transfusional: ramais 9414 ou 9413	Informar: – a necessidade de ativação do Protocolo de Transfusão Maciça, – dados de identificação da parturiente (nome completo, data de nascimento), – setor (Bloco Obstétrico), – nome e número de registro profissional do profissional que faz a solicitação.
• Indicado para pacientes com sangramento agudo grave NÃO CONTROLADO e com sinais de choque hipovolêmico – para os quais a previsão é de uso de grande quantidade de hemocomponentes. • Utilizar o "limiar crítico de administração" (definido como um requisito para ≥ 3 unidades de hemácias em uma hora) e o índice de choque seriado (calculado pela divisão da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica). Esses parâmetros auxiliam no reconhecimento precoce do paciente que necessitará de uma transfusão maciça. • A equipe da Agência Transfusional prepara e libera de modo contínuo os hemocomponentes, o que mantêm a proporção adequada (1:1:1) e agiliza o processo da sua dispensação. • É possível a liberação de hemocomponentes sem prova de compatibilidade. • Há um maior descarte e por este motivo, esse protocolo deve ser interrompido assim que possível.	

Conforme o histórico de atendimento institucional, a maioria das puérperas se encaixa nos critérios de TRANSFUSÃO DE EMERGÊNCIA, ao invés de MACIÇA, e isso evita o descarte desnecessário de hemocomponentes, agiliza o atendimento e evita prejuízos ao atendimento de outros pacientes. A depender da evolução clínica da paciente, a equipe assistencial pode avisar à Agência Transfusional e transicionar a ativação de um protocolo para o outro.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Quadro 3 – Ativação do Protocolo de Transfusão de Hemocomponentes em Situações de Emergência:

Contato com a Agência Transfusional: ramais 9414 ou 9413; ou comparecer pessoalmente à Agência Transfusional	Informar: – a necessidade de ativação do Protocolo de Transfusão de Emergência. – nome completo e o número do CRM do médico prescritor (se prescrição verbal). – nome completo e o número do CRM/COREN do médico ou enfermeiro que está repassando a solicitação para a Agência Transfusional (se prescrição verbal). – nome completo e data de nascimento da paciente que irá ser submetida ao protocolo. – setor onde essa paciente está sendo atendida. – tipo e a localização do sangramento. Verificar se há hemocomponentes já preparados para a paciente, se é possível aguardar a realização, o preparo e a dispensação dos hemocomponentes ou se é necessário solicitar transfusão de hemácias SEM PROVA DE COMPATIBILIDADE.
• Transfusão para pacientes com sangramento agudo grave JÁ CONTROLADO, mas com sinais de choque hipovolêmico, quando a previsão é de uso de poucas unidades de hemocomponentes. • O médico assistente define o tipo e a quantidade de hemocomponente a ser utilizado a cada vez. • É possível a liberação de hemocomponentes sem prova de compatibilidade. • Os hemocomponentes serão preparados sob demanda.	

AÇÕES, CUIDADOS E VIGILÂNCIA MATERNA NO PÓS-PARTO

- Deve-se proporcionar e incentivar o contato pele a pele entre a mãe e o RN, sob a supervisão de um profissional da equipe multidisciplinar, após a avaliação pelo médico pediatra, caso o estado físico do bebê permita. Considerar o Protocolo de Assistência ao RN em Sala de Parto.
- Evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina tais como pesar, medir e dar banho – a não ser que os procedimentos sejam solicitados pela mulher ou sejam realmente necessários para os cuidados imediatos do recém-nascido. Estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida.
- Manter observação rigorosa da puérpera, com avaliações da condição física geral, coloração da pele e mucosas, respiração, sensação de bem-estar e perdas sanguíneas.
- Iniciar verificação do tônus uterino e a loquiação em até 30 minutos, reavaliando a cada 15 minutos nas primeiras 2 horas pós-parto em todas as puérperas, juntamente com a aferição dos dados vitais maternos.
- Reavaliar a região perineal e suturas.
- Considerar ITT REP 02.8 - Assistência ao Puerpério.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

CRITÉRIO DE SAÍDA DO PROTOCOLO

Saída da puérpera e do bebê da sala de parto, com encaminhamento para a enfermaria ou outra unidade.

MONITORAMENTO

- Taxa de cesarianas.
- Proporção de partos normais em gestação de risco habitual assistidos por enfermeiras obstétricas.
- Taxa de episiotomias.
- Taxa de lacerações perineais graves.
- Proporção de recém-nascidos com 37 semanas ou mais de gestação com apgar de 5º minuto ≤ 6.
- Presença de doulas na grade geral de plantões.
- *Check-list* aplicado de cirurgia segura na Obstetrícia.
- Taxa de ativação do protocolo de transfusão maciça pelo Bloco Obstétrico.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os participantes declaram não haver conflito de interesse.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Am. Col. of Obst. and Gyn. ACOG Practice Bulletin No. 116: Management of Intrapartum Fetal Heart Rate Tracings. Obstet Gynecol 2010; 116 (5):1232-1240.

Am. Col. of Obst. and Gyn. Approaches to limit intervention during labor and birth. Obstetrics & Gynecology. ACOG Committee Opinion No. 766. 2019; vol. 133: N. 2 e 164-73.

Am. Col. of Obst. and Gyn. Task Force on Hypertension in Pregnancy. ACOG Hypertension in Pregnancy Task Force. Washington, DC: ACOG; 2013.

Am. College of Obst. and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 106: Intrapartum Fetal Heart Rate Monitoring: Nomenclature, Interpretation, and General Management Principles. 2010. Compendium of Selected Publications, 324-334.

American College of Nurse-Midwives. Providing Oral Nutrition to Women in Labor. Journal of Midwifery & Women's Health, (2016), 61: 528-534. doi:10.1111/jmwh.12515

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Anim-Somuah M, Smyth RMD, Jones L. Epidural versus non-epidural or no analgesia in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD 000331. DOI: 10.1002/14651858.CD000331.pub3.

Aquino C.I, Guida M., Saccone G, Cruz Y, Vitagliano A, Zullo F, Berghella V. Dez. 2018. Perineal massage during labor: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The Journ of Mat Fetal & Neon Med. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2018.1512574?scroll=top&needAccess=true Acesso em: 22 out. 2018.

Ayres de Campos, D., Spong, CY, Chandraharan, E. and, (2015), the FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography. Int. Journ. of Gyn. and Obst., 131: 13-24. doi: 10.1016 / j. ijgo.2015.06.020

Basevi V, Lavender T. Rasurado perineal sistematico en el ingreso a la sala de partos Revision Cochrane traducida. En: La Bibl. Cochrane Plus,2008 N. 2 Oxford: Update Software Ltd disponível em: http://www.update-software.com Traducida de The Cochrane Library, 2008; Issue 2. Chichester,UK: John Wiley & Sons, Ltd.

Bienstock J.L., Eke A. C., Hueppchen N. A. Postpartum Hemorrhage. N Engl J Med 2021; 384:1635-45. DOI: 10.1056/NEJMra1513247

Bidgood KA, Steer PJ. A randomized control study of oxytocin augmentation of labour. 1. Obstetric outcome. BJOG: an international journal of obstetrics & gynaecology. 1987;94(6):512–17.

Blanch G, Lavender T, Walkinshaw S, et al. Dysfunctional labour: A randomised trial. BJOG: An International Journ. of Obstetrics & Gynaecology. 1998;105(1):117-20.

BRASIL. Assistência ao Parto e Nascimento Diretrizes para o cuidado multidisciplinar. Belo Horizonte, 2015. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/protocolo-assistencia_parto_nascimento-13-01-2016.pdf. Acesso em: 22 Out. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. Relatório de Recomendação. Brasília, 2016.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Diretrizes nacionais de assistência ao parto

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

normal. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/2016/Relatorio_Diretriz-PartoNormal_CP.pdf. 26.

Cammu H, Van Eeckhout E. A randomised controlled trial of early versus delayed use of amniotomy and oxytocin infusion in nulliparous labour. Br J Obstet Gynaecol. 1996;103(4):313–18.

Cardozo L, Pearce JM. Oxytocin in active-phase abnormalities of labor: a randomized study. Obstetrics and Gynecology. 1990;75(2):152–7. [PubMed].

Cohen GR, O'Brien WF, Lewis L, et al. A prospective randomized study of the aggressive management of early labor. Am J Obst. 1987;157(5):1174–7.

Dwight E. Hooper, MD, MBA, Jessica Grayson, MD, Emad Elsamadicy, MD Management of intrapartum category I, II, and III fetal heart rate tracings

ENKIN, Murray et al.Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005.

FEBRASGO - Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Pré-eclâmpsia nos seus diversos aspectos. -- São Paulo, 2017. Série Orientações e Recomendações. n. 8, 2017.

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Assistência ao Trabalho de Parto. S.L: Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar. Associação Médica Brasileira. Agência Nacional de Saúde Suplementar. 12 p, jan. 2011.

FIGO Guidelines. Management of the second stage of labor. FIGO Safe Motherhood and Newborn Health (SMNH) Committee, (2012). International Journal of Gynecology & Obstetrics, 119: 111-116. doi:10.1016/j.ijgo.2012.08.002.

Fraser WD, Turcot L, Krauss I, Brisson-Carrol G. Cochrane Database of Systematic Reviews. Oxford: Update Software; 2005. Amniotomy for shortening spontaneous labour. (Cochrane Review).

Jamal A, Kalantari R. High and low dose oxytocin in augmentation of labor. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2004;87:6-8.

Kelso IM, Parsons RJ, Lawrence GF, Arora SS, Edmonds DK, Cooke ID. An assessment of continuous fetal heart rate monitoring in labor. A randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 1978;131(5):526-32.

Lavender T, Alfirevic Z, Walkinshaw S. Effect of different partogram action lines on birth outcomes:

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

A randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2006;108(2):295–302.

Lavender T, Alfirevic Z, Walkinshaw S. Partogram action line study: a randomised trial. Br J Obstet Gynaecol. 1998;105(9):976-80.

Lieberman E, Davidson K, Lee-Parritz A, Shearer E. Changes in fetal position during labor and their association with epidural analgesia. Obstet Gynecol. May 2005;105 (5 Pt 1): 974-982.

Lopez-Zeno JA, Peaceman AM, Adashek JA, et al. A controlled trial of a program for the active management of labor. N Engl J Med. 1992; 326(7): 450-4.

McDonald D, Grant A, Sheridan-Pereira M, Boylan P, Chalmers I. The Dublin randomized controlled trial of intrapartum fetal heart rate monitoring. Am J Obstet Gynecol. 1985;152(5):524-39.

Nipanal, HV, Maurrya, NSK, Susmitha, S. et al. Analysis of Proteinuria Estimation Methods in Hypertensive Disorders of Pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynecology of India. (2018) 68(6): 452-455.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Protocolo Hemorragia pós-parto: prevenção e tratamento, 2016

Portaria SAS/MS nº 743 de 20 de dezembro de 2005 autoriza o enfermeiro obstétrico emitir laudos de AIH procedimento código: 35080019 do grupo: 35150017 da tabela do SIH/SUS.

RAMOS, José Geraldo Lopes; SASS, Nelson; COSTA, Sérgio Hofmeister Martins. Preeclampsia. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro , v. 39, n. 9, p. 496-512, Sept. 2017 ..

Reveiz LGH, Cuervo LG. Enemas durante el trabajo de parto Revision Cochrane traducida. In: La Biblioteca Chchrane Plus, 2008; Numero 1. Oxford: Update Software Ltd. Disponível em: http://www.update-software.com. Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 1. Chichester, UK: John Wiley& Sons, Ltd.

Rouse DJ, McCullough C, Wren AL, et al. Active-phase labor arrest: a randomized trial of chorioamnion management. Obstetrics and Gynecology. 1994;83(6):937–40. [PubMed].

Smyth RMD, Alldred SK, Markham C. Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD006167. DOI:10.1002/14651858. CD006167.pub3.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

Tranquilli AL, Dekker G, Magee L, Roberts J, Sibai BM, Steyn W, Zeeman GG, Brown MA. The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy: A revised statement from the ISSHP. Pregnancy Hypertens.2014;4(2):97-104.

Vintzileos AM, Antsaklis A, Varvarigos I, Papas C, Sofatzis I, Montgomery JT. A randomized trial of intrapartum electronic fetal heart rate monitoring versus intermittent auscultation. Obstet Gynecol. 1993;81(6):899-907.

WHO - World Health Organization. Recommendations for prevention and treatment of maternal peri-partum infections: evidence base. Geneva: World Health Organization; 2015. ISBN 978 92 4 154936 3.

WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Wood C, Renou P, Oats J, Farrell E, Beischer N, Anderson I. A controlled trial of fetal heart rate monitoring in a low-risk obstetric population. Am J Obstet Gynecol. 1981;141(5):527-34.

World Health Organization partograph in management of labour. WHO Maternal Health and Safe Motherhood Programme. Lancet. 1994;343(8910):1399–404.

SIGLAS

Bpm	Batimentos por minuto
CTG	Cardiotocografia
DLE	Decúbito lateral esquerdo
EV	Endovenoso
FC	Frequência cardíaca
FCF	Frequência cardíaca fetal
HIV	Vírus da imunodeficiência humana
HPP	Hemorragia pós-parto
PAD	Pressão arterial diastólica
PAS	Pressão arterial sistólica
RN	Recém-nascido

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

HISTÓRICO DAS VERSÕES

1ª versão

- Elaborada em maio de 2022 por: Willian Schneider Krettli, Flávia Lima Miranda, Kelly Cristina Almeida Borgonove, Priscila de Oliveira Martins, Karen de Lima Prata.
- Avaliado em julho a setembro de 2022 por: René Coulaud Santos da Costa Cruz, Mário Dias Corrêa Júnior, Lêni Márcia Anchieta, Karen de Lima Prata, Paula Nogueira Maia Madeira, José Maria Chaves.
- Responsável técnico: Mário Dias Corrêa Júnior.
- Colocada em consulta pública em agosto de 2022.
- Aprovada em setembro de 2022 por Luciana Cristina dos Santos Silva, gerente de Atenção à Saúde e diretora técnica.

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra por qualquer meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravável, sem a permissão expressa da Alta Administração do Hospital das Clínicas da UFMG (Lei Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).